Латеральная аугментация с одновременной установкой имплантата

Клинический отчёт о случае

Использованный костный материал: 80% дентинного трансплантата Ivory + 20% аутогенной костной стружки (полученной при сверлении) **Применение:** латеральная аугментация, выполненная одновременно с установкой имплантата в области 36 **Выполнил:** д-р Ави Купершлаг



Перейти к содержанию

1 До операции — тонкий альвеолярный гребень

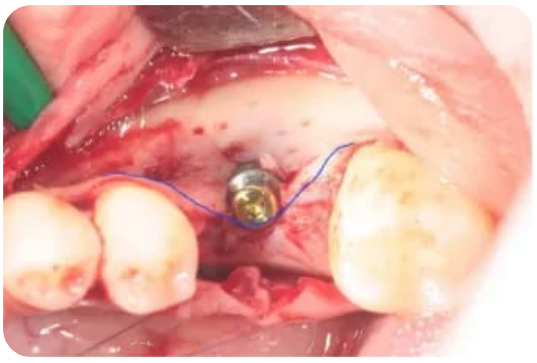
Клинический вид, демонстрирующий тонкий альвеолярный гребень в области зуба 36. Ширина гребня была недостаточной для стандартной установки имплантата без проведения аугментации.



Перейти к содержанию

2 Установка имплантата в области тонкого альвеолярного гребня

Интраоперационный вид, демонстрирующий установку имплантата в узком альвеолярном гребне. Несмотря на ограниченные горизонтальные размеры кости, имплантат был установлен с правильной ангуляцией и достиг первичной стабильности. Обратите внимание на подготовленное ложе и положение имплантата, с чётким доступом для одновременной аугментации.



Перейти к содержанию

3 Боковой (щёчный) вид — тонкий альвеолярный гребень с оголёнными резьбами имплантата

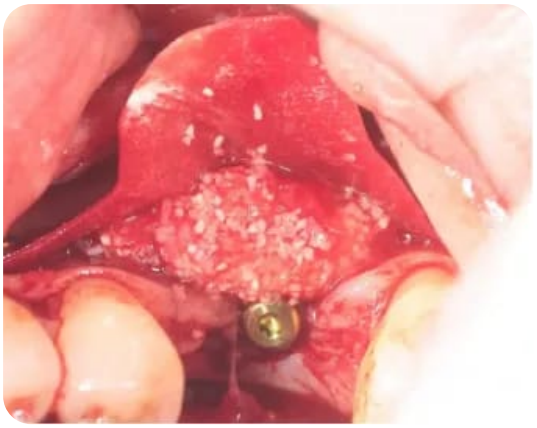
На этом клиническом изображении представлен щёчный вид после установки имплантата в узком гребне. Альвеолярная кость демонстрирует недостаточную горизонтальную ширину, в результате чего часть резьбы имплантата остаётся оголённой. Эта ситуация подчёркивает необходимость одновременной латеральной аугментации кости для обеспечения оптимальной долгосрочной стабильности и полного покрытия имплантата. Видна подготовка ложа с кортикальными перфорациями, что способствует интеграции трансплантата и кровоснабжению зоны.



Перейти к содержанию

4 Латеральная аугментация с использованием дентинного трансплантата Ivory и аутогенной костной стружки, собранной при сверлении (около 20%).

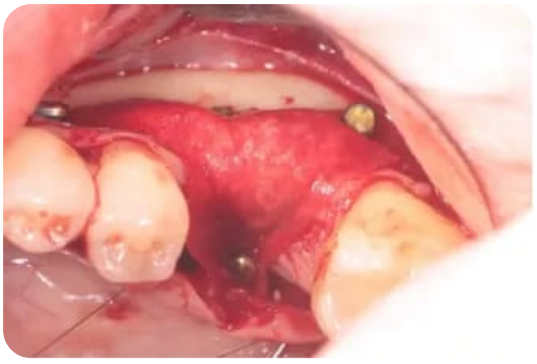
Фаза аугментации процедуры, на которой смесь дентинного трансплантата Ivory и аутогенной костной стружки, собранной при сверлении, заполняет латеральный дефект. Гранулы равномерно распределяются по щёчной поверхности гребня, обеспечивая контакт с собственной костью. Техника направлена на поддержку регенерации и стабильности имплантата в период раннего заживления.



Перейти к содержанию

5 Фиксация мембраны — техника «сосиски»

Перикардиальная мембрана стабилизирована над зоной аугментации с помощью фиксирующих штифтов в соответствии с техникой «сосиски». Этот подход обеспечивает удержание костного материала, поддерживает пространство для регенерации и позволяет безнатяжное закрытие мягких тканей. Мембрана плавно повторяет контур гребня, фиксируя подлежащую смесь дентинного трансплантата Ivory и аутогенной кости.



6 Зашитая область

Зона аугментации зафиксирована безнатяжными швами, что обеспечивает надежное покрытие мягких тканей и оптимальные условия для заживления.



Перейти к содержанию

7 Через четыре месяца после операции

Область демонстрирует хорошее заживление мягких тканей с хорошо очерченным гребнем, что указывает на успешную интеграцию трансплантата.



8 Повторное вскрытие и обнажение имплантата

Через четыре месяца после аугментации при повторном вскрытии выявляется хорошая костная регенерация с плотной, хорошо интегрированной тканью трансплантата вокруг имплантата. Контур гребня и стабильность кости позволили перейти к протетическому этапу лечения.



Перейти к содержанию

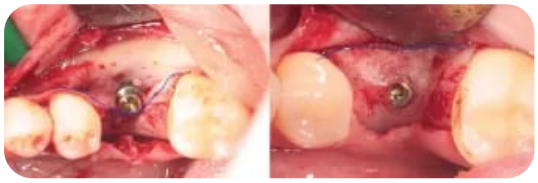
9 Установка формирователя десны

После вскрытия устанавливается формирователь десны. Закрытие мягких тканей выполнено без натяжения, окружающие ткани демонстрируют благоприятное заживление, обеспечивая стабильный контур десны для будущей протетической реставрации.



10 Сравнение до и после аугментации

Прямое сравнение хирургической зоны до и после аугментации демонстрирует явный горизонтальный прирост кости, достигнутый с помощью дентинного трансплантата Ivory в сочетании с аутогенной костью. Ранее оголённые резьбы имплантата теперь полностью покрыты, что свидетельствует об успешной аугментации.



Перейти к содержанию

Результат клинического случая:

Случай иллюстрирует применение дентинного трансплантата Ivory с аутогенной костью при одновременной установке имплантата и латеральной аугментации. Под коллагеновой мембраной с фиксацией через 4 месяца отмечены регенерация в зоне аугментации и стабильность имплантата.